发作频率高→UA［静息型心绞痛CCS IV级 变异型心绞痛

9.2017N48 A 男性，56 岁，一个月 3 次夜间睡眠中因突发心前区疼痛而惊醒，伴出汗，咽部发紧，呼吸不畅，持续 10 分钟自行缓解，白天活动正常，既往发现血压升高 1 年，未经治疗，吸烟 20 年。查体：P 60 次/分，BP 160/80mmHg，双肺正常，心律整，心音正常，双下肢不肿，首选的降压治疗药物是

A.血管紧张素转换酶抑制剂

B.血管紧张素II受体拮抗剂

C.钙通道阻滞剂 硝苯地平

D.β 受体拮抗剂

10.2017N128-129 B

A.溶栓治疗　根本 ACS STEMI×禁 抗板 抗凝 溶栓

B.介入取栓治疗

C.抗凝治疗

D.抗血小板治疗

凝血因子打转转

男性，66 岁，高血压 4 年，半年前房颤，超声心动图示左房大，宜选用的治疗方法是

男性，72 岁，1 周前急性前壁心肌梗死，PCI 治疗，左房前降支植入药物洗脱支架，宜选用的治疗方法是

憋憋出问题

11.2019N47 A 男性，58 岁。因活动后心悸、胸闷、气短半年来院，15 年前发现血压高，从未诊治，吸烟 30 年。父亲 40 岁死于心肌梗死。查体：P 82 次/分，BP 150/70mmHg，双肺(-)，心界向左下扩大，心尖部可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音。超声心动图示左心房增大、左室壁增厚、二尖瓣瓣尖稍增厚，室壁运动正常。应首先考虑的诊断是

左室大

二闭

A.高血压心脏病

B.风湿性心瓣膜病 超声没有报反流

C.扩张型心肌病

D.冠状动脉性心脏病

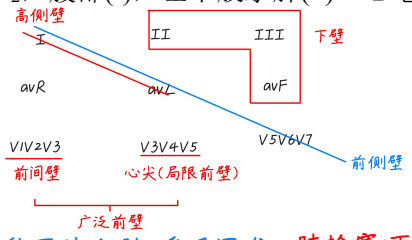
发作频率高→UA

CCS IV级与活动不受限矛盾　步行来院:相当于自己给自己做个平板

12.2019N76-78 A 女性，49 岁，近 2 个月无诱因出现心前区气促，憋闷，持续 10 分钟至半小时不等，发作时伴乏力、四肢麻木、手心出汗，活动不受限。1 小时来症状再发并持续不缓解，步行来院。既往高血脂，无其他病史。其父患心脏病猝死。查体：P 80 次/分，R 16 次/分，BP 130/70mmHg，肥胖体型，双肺(-)，心界不大，心律整，心尖部可闻及 2/6 级收缩期杂音，$A_2=P_2$，腹部(-)，左下肢水肿(±)。心电图提示：III、aVF、V_5 导联 T 波低平。

功能性杂音

只有T波倒置无意义,必须伴有ST段改变



患者生命体征平稳且无胸痛表现

76.根据目前资料，患者最不可能的疾病是

A.心脏神经官能症 阳间病例题选A

B.急性心肌梗死

C.不稳定型心绞痛

D.肺栓塞 肥胖是肺栓塞危险因素之一、不对称下肢水肿、呼吸困难

肺栓塞:下肢深V血栓形成
突发呼吸困难
P2亢进(栓塞程度轻,对肺循环影响小,无肺A高压)
右心功能不全

77.此时给予患者最正确的处理措施是

A.对症处理，临床观察

B.保证氧供，急诊溶栓

C.积极抗凝，抗血小板

D.血运重建，急诊介入

78.患者症状缓解后 2 周再次来院，为明确诊断，此时首选的检查是

A.超声心动图 心梗并发症

答案：9-12 C CD A BAD